# INFORMACIÓN PARA PRESCRIBIR

## 1. IDENTIFICACIÓN DEL MEDICAMENTO

**Nombre comercial o de marca del medicamento**

TEPEZZA®

**Denominación común internacional**

Teprotumumab

**Composición**

500 mg de teprotumumab como polvo liofilizado de blanco a color hueso en un vial de dosis única para dilución y reconstitución.

**Forma Farmacéutica**

Polvo liofilizado para infusión intravenosa

**Concentración**

500 mg

**Condición de Venta**

Venta bajo fórmula médica

**Vía de administración**

Administre la solución diluida por vía intravenosa durante 90 minutos durante las primeras dos infusiones. Si es bien tolerada, el tiempo mínimo de las siguientes infusiones se puede reducir a 60 minutos. Si no es bien tolerada, el tiempo mínimo de las siguientes infusiones se debe mantener en 90 minutos.

No administre como pulso o bolo intravenoso. TEPEZZA no se debe infundir en forma concomitante con otros agentes.

## 2. INFORMACIÓN PARA EL PRESCRIPTOR

**Indicaciones**

Teprotumumab (TEPEZZA) se indica en adultos para el tratamiento de la enfermedad ocular tiroidea activa moderada a severa con proptosis y/o diplopía.

**Características Farmacológicas**

**Mecanismo de acción**

El mecanismo de acción en pacientes con enfermedad ocular tiroidea no se ha caracterizado completamente. Teprotumumab se transporta hacia el IGF-1R bloqueando e inhibiendo su activación y señal.

**Farmacodinámica**

No se han realizado estudios formales de farmacodinámica con teprotumumab.

**Farmacocinética**

La farmacocinética de teprotumumab se describió en un modelo de población de dos compartimientos PK basado en datos de 40 pacientes con enfermedad ocular tiroidea que recibieron una infusión intravenosa inicial de 10 mg/kg, seguida de infusiones de 20 mg/kg de TEPEZZA cada 3 semanas en

un ensayo clínico. Siguiendo este régimen, la media (±desviación estándar) estimada para el área en estado estacionario bajo la curva de concentración (AUC), el nivel máximo (Cmax), y el nivel mínimo (Ctrough) de concentración de teprotumumab fueron 138 (±34) mg•hr/mL, 632 (±139) mcg/mL, y 176 (±56) mcg/mL, respectivamente.

Distribución
Siguiendo el régimen recomendado de TEPEZZA, la media de población PK estimada (±desviación estándar) para los volúmenes central y periférico de distribución de teprotumumab fueron 3,26 (±0,87) L y 4,32 (±0,67) L, respectivamente. La media (±desviación estándar) estimada de depuración intercompartimentada fue 0,74 (±0,16) L/día.

Eliminación
Siguiendo el régimen de dosis recomendado de TEPEZZA, la media estimada de la población PK (±desviación estándar) para la depuración de teprotumumab fue de 0,27 (±0,08) L/día y para la semivida de eliminación fue de 20 (±5) días.

*Metabolismo*
El metabolismo de teprotumumab no se ha caracterizado completamente. Sin embargo, se espera que teprotumumab se metabolice mediante la proteólisis.

Poblaciones específicas
No se observaron diferencias clínicamente significativas en la farmacocinética de teprotumumab durante la administración de TEPEZZA basadas en la edad del paciente (18-80 años), género, raza/etnia (103 blancos, 10 negros y 3 asiáticos), peso (46-169 kg), insuficiencias renales leves a moderados (depuración de creatinina 30 a 89 mL/min estimada por la ecuación de Cockcroft-Gault), niveles de bilirrubina (2,7-24,3 mcmol/L), niveles de aspartato aminotransferasa (AST) (11-221 U/L) o niveles de alanina aminotransferasa (ALT) (7-174 U/L). Se desconocen los efectos de insuficiencia hepática de la farmacocinética de teprotumumab.

Interacciones farmacológicas
No se han realizado estudios evaluando la interacción potencial de TEPEZZA.

**Estudios toxicológicos no clínicos**

Carcinogénesis, mutagénesis, deterioro de la fertilidad

Carcinogénesis
No se ha evaluado a largo plazo el potencial carcinogénico de TEPEZZA en estudios en animales a largo plazo.

Mutagénesis
No se ha evaluado el potencial genotóxico de TEPEZZA.

Deterioro de la fertilidad
No se han realizado estudios de fertilidad con TEPEZZA.

**Estudios clínicos**

Se evaluó TEPEZZA en 2 estudios aleatorizados, doblemente enmascarados controlados con placebo en 171 pacientes con enfermedad ocular tiroidea: Estudio 1 (NCT01868997) y Estudio 2 (NCT03298867). Se aleatorizaron a los pacientes para que recibieran TEPEZZA o placebo en una proporción de 1:1. Tanto los pacientes que fueron tratados con infusiones intravenosas (con 10 mg/kg en la primera infusión y con 20 mg/kg en las 7 infusiones restantes) cada 3 semanas por un total de 8. Los pacientes tenían un diagnóstico clínico de oftalmopatía tiroidea con síntomas o eran eutiroideos o tenían niveles de triyodotironina menores del 50% por arroba o por debajo de los límites normales. No se permitió tratamiento quirúrgico previo para enfermedad ocular tiroidea. La proptosis varió de 16 a 33 mm y 125 pacientes (73%) tenían valores iniciales de diplopía.

Se aleatorizaron un total de 84 pacientes con TEPEZZA y 87 con placebo. La media de edad era de 52 años (rango de 20 a 79 años), el 86% eran blancos, el 9% eran negros o afroamericanos, el 4% eran asiáticos y 1% se identificó como otro. La mayoría (73%) eran mujeres. En los valores iniciales el 27% eran fumadores.

El índice de respuesta de la proptosis a la semana 24 se definió como el porcentaje de pacientes con ≥ 2 mm de reducción en la proptosis en el ojo del estudio a partir del valor inicial, sin deterioro en el ojo que no era del estudio (≥ 2 mm de aumento) en la proptosis. Las evaluaciones adicionales incluyeron signos y síntomas de oftalmopatía tiroidea: dolor, dolor ocular al fijar la mirada, hinchazón, eritema ocular, enrojecimiento, quemosis, inflamación, puntaje de actividad clínica de asesoramiento de la visión funcional y hallazgos en el paciente. Los resultados de la proptosis se encuentran en la Tabla 1.

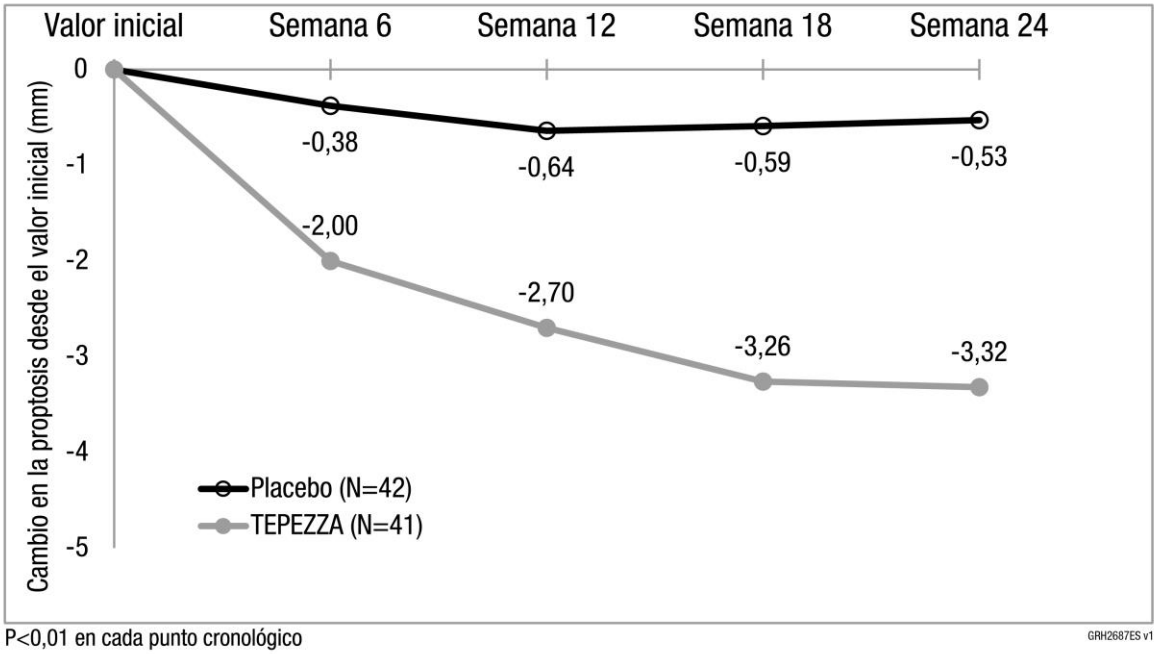
**Tabla 1. Resultados de eficacia en pacientes con oftalmopatía tiroidea en el Estudio 1 y 2**

| | Estudio 1 | | | Estudio 2 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Teprotumumab (N = 42) | Placebo (N = 45) | Diferencia (95% CI) | Teprotumumab (N = 41) | Placebo (N = 42) | Diferencia (95% CI) |
| Índice de respuesta de la proptosis a la semana 24, % (n)[1] | 71% (30) | 20% (9) | 51% (33, 69) | 83% (34) | 10% (4) | 73% (59, 88) |
| | | | | | | |
| Proptosis (mm) cambio en la media de los valores iniciales en la semana 24, Promedio LS (SE)[2] | -2,5 (0,2) | -0,2 (0,2) | -2,3 (-2,8; -1,8) | -2,8 (0,2) | -0,5 (0,2) | -2,3 (-2,8; -1,8) |

[1] La diferencia y su correspondiente intervalo de confianza (CI) del 95% se basa en el índice ponderado de la diferencia dentro de cada estrato aleatorizado (fumador, no fumador) mediante ponderaciones CMH.
[2] Se obtuvieron los resultados de las MMRM con una matriz de covarianza no estructurada e incluyeron el tratamiento, la condición de fumador, los valores de referencia inicial, la visita, el tratamiento por la visita y la visita por la interacción del valor de referencia inicial como efectos fijos. Un cambio del valor de referencia inicial de 0 se imputó en la primera visita inicial para cualquier sujeto sin un valor luego de la referencia inicial.

En el Estudio 2, se midió la mejora de la proptosis observando el cambio de la media desde la referencia inicial en la semana 6 y como continuó mejorando hasta la semana 24, como se muestra en la Figura 1. Se observaron resultados similares en el Estudio 1.

**Figura 1. Cambio en la proptosis desde la referencia inicial a lo largo de 24 semanas en el Estudio 2**




TEPEZZA llevó también a una mejora en el ojo “compañero” menos afectado.

La diplopía (visión doble) se evaluó en un subgrupo de pacientes que tenían diplopía en la referencia inicial del Estudio 1 y del Estudio 2. Los resultados están en la Tabla 2.

**Tabla 2. Diplopía en pacientes con oftalmopatía tiroidea en Estudio 1 y 2**

| Estadística | TEPEZZA (n = 66) | Placebo (n = 59) |
|---|---|---|
| Diplopía<br>Índice[a] de respuesta de la proptosis a la semana 24, % (n) | 53% (35) | 25% (15) |

P< 0,01

[a] Se evaluó la diplopía en una escala de 4 puntos, donde el puntaje iba de 0, para los pacientes sin diplopía, a 3, para la diplopía constante. Se definió como un respondedor a la diplopía a un paciente con diplopía en la referencia inicial > 0 y un puntaje de 0 a la semana 24.

Después de interrumpir el tratamiento en el Estudio 1, 53% de los pacientes (16 de 30 pacientes) que eran respondedores de proptosis a la semana 24 mantuvieron su respuesta a la proptosis a la semana 51 después de su última infusión con TEPEZZA. El 67% de los pacientes (12 de 18) que fueron respondedores de diplopía a la semana 24 mantuvieron su respuesta a la diplopía a la semana 51 después de su última infusión con TEPEZZA.

<u>Subgrupos</u>
No se identificaron diferencias en la examinación de la edad y género de los subgrupos en la respuesta a TEPEZZA, dentro de estos subgrupos. La reducción de la proptosis fue similar entre los fumadores y los no fumadores en ambos estudios.

## Contraindicaciones

Ninguna

## Advertencias y precauciones especiales de empleo

### Reacciones a la infusión

TEPEZZA puede causar reacciones a la infusión. Las reacciones a la infusión se informaron en aproximadamente el 4% de los pacientes tratados con TEPEZZA. Los signos y síntomas de reacciones relacionadas con la infusión incluyen aumentos transitorios de la presión arterial, calor, taquicardia, dolor de cabeza y dolor muscular. Las reacciones a la infusión pueden ocurrir durante cualquier infusión o dentro de 1,5 h después de la infusión. Las reacciones a la infusión informadas fueron usualmente leves o moderadas en cuanto a su gravedad y se pueden solucionar con corticoesteroides y antihistamínicos. Se debe considerar la medicación previa a los pacientes que experimentan una reacción a la infusión con un antihistamínico, un antipirético, un corticoesteroide y/o se deberá administrar todas las infusiones siguientes a una velocidad más lenta.

### Exacerbación de Enfermedad de Intestino Irritable preexistente

TEPEZZA puede causar la exacerbación de una enfermedad de Intestino Irritable preexistente (IBD). Vigile a los pacientes con una IBD por brotes de la enfermedad. Si se sospecha una exacerbación de IBD, considere interrumpir TEPEZZA.

### Hiperglucemia

La hiperglucemia o el aumento de glucosa en sangre puede ocurrir en pacientes tratados con TEPEZZA. En los ensayos clínicos, el 10% de los pacientes (dos tercios de los cuales tenían diabetes preexistente o tolerancia alterada a la glucosa) experimentaron hiperglucemia. Las complicaciones relacionadas con la hiperglucemia se deben controlar con medicación especial para la glucemia, si es necesario.

Vigile que los pacientes no tengan la glucosa en sangre elevada o síntomas de hiperglucemia mientras estén en tratamiento con TEPEZZA. Los pacientes con diabetes preexistente deben estar bajo control de glucemia apropiado antes de recibir TEPEZZA.

## Uso En Poblaciones Específicas

### Embarazo

Resumen de los riesgos

Según los hallazgos hechos en animales y en su mecanismo de acción de inhibir el factor de crecimiento insulinoide de tipo 1 (IGF-1R), TEPEZZA puede causar daño fetal cuando se administra a una mujer embarazada. No se han llevado a cabo estudios adecuados y controlados con TEPEZZA en mujeres embarazadas. No hay suficiente información de TEPEZZA usada en mujeres embarazadas como para informar cualquier riesgo de efectos adversos relacionados con el fármaco. La exposición intra útero de teprotumumab con una dosis por semana de teprotumumab en monos cynomolgus durante el embarazo resultó en trastornos externos y óseos. La exposición a teprotumumab puede llevar a un aumento de la pérdida fetal *[ver datos]*. Por lo tanto, TEPEZZA no debe usarse durante el embarazo y se deben implementar formas correctas de anticoncepción antes de iniciar el tratamiento, durante el tratamiento y los 6 meses después de la última dosis de TEPEZZA. Si la paciente se embaraza durante el tratamiento, se debe discontinuar TEPEZZA y se debe informar a la paciente sobre los posibles riesgos fetales.

Se desconocen los antecedentes de malformaciones congénitas graves y de abortos para la población indicada. En EE. UU. se estima que los antecedentes de riesgos estimados en la población general de defectos congénitos y abortos en embarazos clínicamente diagnosticados son de 2% a 4% y de 15% a 20%, respectivamente.

Datos

*Datos de animales*
En un estudio piloto de desarrollo embriofetal, se les administró a siete monas cynomolgus embarazadas una dosis a nivel intravenoso de teprotumumab 75 mg/kg (2,8 dosis máxima recomendada en humanos (MRHD) según AUC) una vez por semana desde la gestación al día 20 hasta el final de la gestación. La incidencia de abortos fue más alta en el grupo tratado con teprotumumab comparado con el grupo de referencia. Teprotumumab causa restricción del desarrollo fetal durante el embarazo, pérdida del tamaño y peso en la cesárea, disminución del peso y tamaño placentario y disminución del volumen de líquido amniótico. Se observaron múltiples alteraciones esqueléticas y externas en cada feto expuesto, que incluyen: malformaciones craneales, hipotelorismo, micrognatia, nariz fileña y trastornos en la osificación de huesos del cráneo, esternebras, cárpales, tarsales y dientes. El nivel sin efectos adversos observados en madres fue en la dosis de prueba de teprotumumab de 75 mg/kg (NSEAO).

Según el mecanismo de acción de inhibición de IGF-1R, la exposición posnatal a teprotumumab puede causar daño.

**Lactancia**

Resumen de los riesgos
No hay información sobre la presencia de TEPEZZA en la leche humana, los efectos en infantes en lactancia o los efectos en la producción de leche.

**Hombres y mujeres en edad reproductiva**

Anticonceptivos
*Mujeres*
Según su mecanismo de acción de inhibidor del factor de crecimiento insulinoide de tipo 1 IGF-1R, TEPEZZA puede causar daño fetal si se administra a una mujer embarazada *[ver Uso en poblaciones específicas]*. Se le aconseja a las mujeres en edad reproductiva que usen un método anticonceptivo eficaz antes de iniciar el tratamiento con TEPEZZA, durante y 6 meses después de la última dosis de TEPEZZA.

**Uso pediátrico**

No se ha establecido la seguridad ni la efectividad en pacientes pediátricos.

**Uso geriátrico**

De los 171 pacientes en dos ensayos aleatorizados, 15% eran mayores de 65 años o más, el otro número de pacientes de 65 años o más fue similar entre los grupos de tratamiento. No hubo diferencias generales en la eficacia o seguridad entre los pacientes de 65 años o más y los pacientes más jóvenes (menores de 65 años de edad).

**Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción**

No se han realizado estudios evaluando la interacción potencial de TEPEZZA

**Condición de almacenamiento y tiempo de vida útil sin abrir**

2 años

TEPEZZA (teprotumumab) polvo liofilizado para infusión intravenosa se suministra como un polvo liofilizado estéril de color blanco a color hueso, sin conservantes, está disponible en la siguiente presentación comercial:

| |
|---|
| Caja que contiene un vial de dosis única de 500 mg |

Refrigere a una temperatura de 2°C a 8°C en su caja original hasta el momento de su uso y protéjalo de la luz. No congelar.

MANTENGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

## Posología y Modo de uso

### Dosis recomendada

La dosis recomendada de TEPEZZA es una infusión intravenosa de 10 mg/kg para la dosis inicial, seguida de una infusión intravenosa de 20 mg/kg cada tres semanas por 7 infusiones adicionales.

### Reconstitución y preparación

Paso 1: Calcule la dosis (mg) y determine el número de viales que se necesitan para la posología de 10 o 20 mg/kg, basado en el peso del paciente. Cada vial de TEPEZZA contiene 500 mg del anticuerpo teprotumumab.

Paso 2: Use la técnica apropiada de asepsia y diluya cada vial de TEPEZZA con 10 mL de agua destilada estéril para la inyección, USP. Asegúrese de que el flujo del diluyente no esté dirigido al polvo liofilizado, que posee apariencia compacta. No agite, sino mezcle suavemente la solución, rotando el vial hasta que el polvo liofilizado se disuelva. La solución reconstituida tiene un volumen de 10,5 mL. Retire 10,5 mL de la solución reconstituida para obtener 500 mg. Luego de la reconstitución la concentración final es de 47,6 mg/mL.

Paso 3: La solución de TEPEZZA, una vez reconstituida, debe diluirse en solución de cloruro de sodio al 0,9%, USP, antes de la infusión. Antes de añadir el volumen reconstituido de TEPEZZA necesario para la dosis del paciente, se recomienda retirar de la bolsa para infusión con una jeringa estéril un volumen equivalente de solución inyectable de cloruro de sodio al 0,9%, USP. Descarte la solución de cloruro de sodio al 0,9%, USP retirada de la bolsa para infusión.

Paso 4: Retire el volumen requerido de lo(s) vial(es) de TEPEZZA reconstituido basado en el peso del paciente (en kg) y transfiera a la bolsa para infusión que contiene la solución de cloruro de sodio al 0,9%, USP para preparar la solución diluida con un total de 100 mL (para una dosis menor a 1.800 mg) o 250 mL (para una dosis de 1.800 mg o mayor). Mezcle la solución diluida invirtiéndola suavemente. No sacuda.

El producto no contiene conservantes. El tiempo total de almacenamiento combinado de la solución reconstituida de TEPEZZA en el vial y en la solución diluida en la bolsa de la infusión con la solución para inyección de cloruro de sodio al 0,9%, USP es de un total de 4 horas a temperatura ambiente 20°C a 25°C o hasta 48 horas en refrigeración protegida de la luz 2°C a 8°C. Si se refrigera antes de la administración, permita que la solución diluida alcance la temperatura ambiente antes de realizar la infusión.

La solución parenteral se deben inspeccionar visualmente, si la solución y el contenedor lo permiten, para ver si hay partículas en suspensión o decoloración antes de la infusión. Después de la reconstitución, TEPEZZA es una solución casi incolora o ligeramente amarronada, de color claro a opalescente, que no posee partículas en suspensión. Descarte la solución si se observan partículas en suspensión o decoloración.

No congele la solución reconstituida o la solución diluida.

Descarte el(los) vial(es) y todo el contenido no utilizado.

No se han observaron incompatibilidades entre TEPEZZA y bolsas de polietileno (PE), cloruro de polivinilo (PVC), poliuretano (PUR), poliolefina (PO) o equipos de administración intravenosa.

### Administración

Administre la solución diluida por vía intravenosa durante 90 minutos para las primeras dos infusiones. Si es bien tolerada, el tiempo mínimo de las siguientes infusiones se puede reducir a 60 minutos. Si no es bien tolerada, el tiempo mínimo de las siguientes infusiones se debe mantener en 90 minutos.

No administre como pulso o bolo intravenoso. TEPEZZA no se debe infundir en forma concomitante con otros agentes.

**Reacciones Adversas**

Las siguientes reacciones adversas clínicamente significativas se describen en otra parte del instructivo:

Reacciones a la infusión *[ver Advertencias y precauciones especiales de empleo]*
Exacerbación de enfermedad de intestino irritable preexistente *[ver Advertencias y precauciones especiales de empleo]*
Hiperglucemia *[ver Advertencias y precauciones especiales de empleo]*

**Experiencia de ensayos clínicos**

Debido a que los ensayos clínicos se llevaron a cabo bajo condiciones sumamente diversas, los índices de reacciones adversas observados en los ensayos clínicos de un fármaco no se pueden comparar directamente con los índices de otro fármaco en el ensayo clínico, y pueden no reflejar los índices observados en la práctica.

Se evaluó la seguridad de TEPEZZA en dos estudios clínicos aleatorizados de doblemente enmascarados controlados con placebo (Estudio 1 [NCT:01868997] y Estudio 2 [NCT:03298867]) que consistieron de 170 pacientes con enfermedad ocular tiroidea (84 recibieron TEPEZZA y 86 recibieron placebo). Tanto los pacientes que fueron tratados con TEPEZZA (con 10 mg/kg en la primera infusión y con 20 mg/kg en las 7 infusiones restantes) como a los que se les administró placebo recibieron una infusión intravenosa cada 3 semanas para un total de 8. La mayoría de los pacientes completaron 8 infusiones (el 89% de los que recibieron TEPEZZA y el 93% de los que recibieron placebo).

Las reacciones adversas más comunes ocurrieron en una incidencia mayor en el grupo TEPEZZA (≥ 5%) que en el grupo de referencia durante el periodo del tratamiento en el Estudio 1 y en el Estudio 2 están resumidas en la Tabla 3.

Además, se informaron desórdenes menstruales (amenorrea, metrorragia, dismenorrea) en aproximadamente el 23% (5 de 22 pacientes) de las mujeres menstruantes tratadas con TEPEZZA comparados con el 4% (1 de 25 pacientes) tratados con placebo en los ensayos clínicos.

**Tabla 3. Reacciones adversas que ocurrieron en más del 5% de los pacientes tratados con TEPEZZA y con mayor incidencia que el placebo**

| Reacciones adversas | TEPEZZA<br>N = 84<br>N (%) | Placebo<br>N = 86<br>N (%) |
|---|---|---|
| Espasmos musculares | 21 (25%) | 6 (7%) |
| Náuseas | 14 (17%) | 8 (9%) |
| Alopecia | 11 (13%) | 7 (8%) |
| Diarrea | 10 (12%) | 7 (8%) |
| Fatiga[a] | 10 (12%) | 6 (7%) |
| Hiperglucemia[b] | 8 (10%) | 1 (1%) |
| Insuficiencia auditiva[c] | 8 (10%) | 0 |
| Disgeusia | 7 (8%) | 0 |
| Dolor de cabeza | 7 (8%) | 6 (7%) |
| Sequedad de la piel | 7 (8%) | 0 |

[a] Fatiga incluye astenia
[b] Hiperglucemia incluye un incremento de la glucosa en sangre
[c] Insuficiencia auditiva (incluye sordera, disfunción de las trompas de Eustaquio, hiperacusia, hipoacusia y autofonia)

**Inmunogenicidad**

Existe la posibilidad de inmunogenicidad, como con todas las proteínas terapéuticas. La detección de la formación de anticuerpos es altamente dependiente de la sensibilidad y la especificidad del ensayo.

En un estudio controlado con placebo con TEPEZZA, 1 de 42 pacientes tratados con el placebo tuvieron niveles detectables de anticuerpos antifármaco en suero. En un estudio controlado con placebo, ninguno de 41 pacientes tratados con TEPEZZA tuvieron niveles detectables de anticuerpos

antifármaco en suero.

**Sobredosis**

No hay información disponible de pacientes que hayan recibido una sobredosis.

**Fabricante del Producto Terminado y Acondicionador:**
Patheon Italia s.p.A
Ferentino - Italia

**Titular e Importador**

**Titular**
Amgen Biotecnológica S.A.S
Bogotá D.C. – Colombia

**Importador y Distribuidor:**
Amgen Biotecnológica S.A.S
Bogotá D.C. – Colombia

**Registro Sanitario**
INVIMA 2024MBT-0000125

TEP-CO-PI-001(es)
Noviembre-2024

## INSERTO PARA EL PACIENTE

### 1. Qué contiene este medicamento?

TEPEZZA® (teprotumumab) polvo liofilizado para infusión intravenosa se suministra como un polvo liofilizado estéril de color blanco a color hueso, sin conservantes. Cada vial de dosis única contiene 500 mg de teprotumumab, L- histidina (7,45 mg), L-histidina clorhidrato monohidrato (31,8 mg), polisorbato 20 (1 mg) y dihidrato de trehalosa (946 mg). Después de la reconstitución con 10 mL de agua estéril para la inyección, USP, la concentración final es de 47,6 mg/mL con un pH de 5,5.

### 2. Cómo funciona este medicamento?

Teprotumumab es un inhibidor del factor de crecimiento insulinoide de tipo 1 (IGF-1R), es un anticuerpo monoclonal humano IgG1 producido en las células del ovario de hámster chino (CHO-DG44). Tiene un peso molecular de aproximadamente 148 kilodaltons.

El mecanismo de acción en pacientes con enfermedad ocular tiroidea no se ha caracterizado completamente. Teprotumumab se transporta hacia el IGF-1R bloqueando e inhibiendo su activación y señal.

### 3. Para qué se usa?

Es un inhibidor del factor de crecimiento insulinoide de tipo 1 indicado en adultos para el tratamiento de la enfermedad ocular tiroidea activa moderada a severa con proptosis y/o diplopía.

### 4. Cuándo no debo usar este medicamento?

No se ha evidenciado contraindicaciones.

### 5. Qué cuidados debo tener antes, durante y después de recibir este medicamento?

<u>Reacciones a la infusión</u>

TEPEZZA puede causar reacciones a la infusión. Las reacciones a la infusión se informaron en aproximadamente el 4% de los pacientes tratados con TEPEZZA. Los signos y síntomas de reacciones relacionadas con la infusión incluyen aumentos transitorios de la presión arterial, calor, taquicardia, dolor de cabeza y dolor muscular. Las reacciones a la infusión pueden ocurrir durante cualquier infusión o dentro de 1,5 h después de la infusión. Las reacciones a la infusión informadas fueron usualmente leves o moderadas en cuanto a su gravedad y se pueden solucionar con corticoesteroides y antihistamínicos. Se debe considerar la medicación previa a los pacientes que experimentan una reacción a la infusión con un antihistamínico, un antipirético, un corticoesteroide y/o se deberá administrar todas las infusiones siguientes a una velocidad más lenta.

<u>Exacerbación de Enfermedad de Intestino Irritable preexistente</u>

TEPEZZA puede causar la exacerbación de la enfermedad de Intestino Irritable preexistente (IBD). Vigile a los pacientes con una IBD por brotes de la enfermedad. Si se sospecha una exacerbación de IBD, considere interrumpir TEPEZZA.

<u>Hiperglucemia</u>

La hiperglucemia o el aumento de glucosa en sangre puede ocurrir en pacientes tratados con TEPEZZA. En los ensayos clínicos, el 10% de los pacientes (dos tercios de los cuales tenían diabetes preexistente o tolerancia alterada a la glucosa) experimentaron hiperglucemia. Las complicaciones relacionadas con la hiperglucemia se deben controlar con medicación especial para la glucemia, si es necesario.

Vigile que los pacientes no tengan la glucosa en sangre elevada o síntomas de hiperglucemia mientras estén en tratamiento con TEPEZZA. Los pacientes con diabetes preexistente deben estar bajo control de glucemia apropiado antes de recibir TEPEZZA.

## 6. Como debo usar este medicamento?

La dosis recomendada de TEPEZZA es una infusión intravenosa de 10 mg/kg para la dosis inicial, seguida de una infusión intravenosa de 20 mg/kg cada tres semanas por 7 infusiónes adicionales.

Reconstitución y preparación

Paso 1: Calcule la dosis (mg) y determine el número de viales que se necesitan para la posología de 10 o 20 mg/kg, basado en el peso del paciente. Cada vial de TEPEZZA contiene 500 mg del anticuerpo teprotumumab.

Paso 2: Use la técnica apropiada de asepsia y diluya cada vial de TEPEZZA con 10 mL de agua destilada estéril para la inyección, USP. Asegúrese de que el flujo del diluyente no esté dirigido al polvo liofilizado, que posee apariencia compacta. No agite, sino mezcle suavemente la solución, rotando el vial hasta que el polvo liofilizado se disuelva. La solución reconstituida tiene un volumen de 10,5 mL. Retire 10,5 mL de la solución reconstituida para obtener 500 mg. Luego de la reconstitución la concentración final es de 47,6 mg/mL.

Paso 3: La solución de TEPEZZA, una vez reconstituida, debe diluirse en solución de cloruro de sodio al 0,9%, USP, antes de la infusión. Antes de añadir el volumen reconstituido de TEPEZZA necesario para la dosis del paciente, se recomienda retirar de la bolsa para infusión con una jeringa estéril un volumen equivalente de solución inyectable de cloruro de sodio al 0,9%, USP. Descarte la solución de cloruro de sodio al 0,9%, USP retirada de la bolsa para infusión.

Paso 4: Retire el volumen requerido de el(los) vial(es) de TEPEZZA reconstituido basado en el peso del paciente (en kg) y transfiera a la bolsa para infusión que contiene la solución de cloruro de sodio al 0,9%, USP para preparar la solución diluida con un total de 100 mL (para una dosis menor a 1.800 mg) o 250 mL (para una dosis de 1.800 mg o mayor). Mezcle la solución diluida invirtiéndola suavemente. No sacuda.

El producto no contiene conservantes. El tiempo total de almacenamiento combinado de la solución reconstituida de TEPEZZA en el vial y en la solución diluida en la bolsa de la infusión con la solución para inyección de cloruro de sodio al 0,9%, USP es de un total de 4 horas a temperatura ambiente 20°C a 25°C o hasta 48 horas en refrigeración protegida de la luz 2°C a 8°C. Si se refrigera antes de la administración, permita que la solución diluida alcance la temperatura ambiente antes de realizar la infusión.

La solución parenteral se debe inspeccionar visualmente, si la solución y el contenedor lo permiten, para ver si hay partículas en suspensión o decoloración antes de la infusión. Después de la reconstitución, TEPEZZA es una solución casi incolora o ligeramente amarronada, de color claro a opalescente, que no posee partículas en suspensión. Descarte la solución si se observan partículas en suspensión o decoloración.

No congele la solución reconstituida o la solución diluida.

Descarte el(los) vial(es) y todo el contenido no utilizado.

No se han observaron incompatibilidades entre TEPEZZA y bolsas de polietileno (PE), cloruro de polivinilo (PVC), poliuretano (PUR), poliolefina (PO) o equipos de administración intravenosa.

Administración
Administre la solución diluida por vía intravenosa durante 90 minutos para las primeras dos infusiones. Si es bien tolerada, el tiempo mínimo de las siguientes infusiones se puede reducir a 60 minutos. Si no es bien tolerada, el tiempo mínimo de las siguientes infusiones se debe mantener en 90 minutos.

No administre como pulso o bolo intravenoso. TEPEZZA no se debe infundir en forma concomitante con otros agentes.

## 7. Que problemas me puede causar este medicamento?

Las siguientes reacciones adversas clínicamente significativas se describen en otra parte del instructivo:

Reacciones a la infusión
Exacerbación de enfermedad de intestino irritable preexistente
Hiperglucemia

Experiencia de ensayos clínicos

Debido a que los ensayos clínicos se llevaron a cabo bajo condiciones sumamente diversas, los índices de reacciones adversas observados en los ensayos clínicos de un fármaco no se pueden comparar directamente con los índices de otro fármaco en el ensayo clínico, y pueden no reflejar los índices observados en la práctica.

Se evaluó la seguridad de TEPEZZA en dos estudios clínicos aleatorizados doblemente enmascarados controlados con placebo (Estudio 1 [NCT:01868997] y Estudio 2 [NCT:03298867]) que consistieron de 170 pacientes con enfermedad ocular tiroidea (84 recibieron TEPEZZA y 86 recibieron placebo). Tanto los pacientes que fueron tratados con TEPEZZA (con 10 mg/kg en la primera infusión y con 20 mg/kg en las 7 infusiones restantes) como a los que se les administró placebo recibieron una infusión intravenosa cada 3 semanas para un total de 8. La mayoría de los pacientes completaron 8 infusiones (el 89% de los que recibieron TEPEZZA y el 93% de los que recibieron placebo).

Las reacciones adversas más comunes ocurrieron en una incidencia mayor en el grupo TEPEZZA (≥ 5%) que en el grupo de referencia durante el periodo del tratamiento en el Estudio 1 y en el Estudio 2 están resumidas en la Tabla 1.

Además, se informaron desórdenes menstruales (amenorrea, metrorragia, dismenorrea) en aproximadamente el 23% (5 de 22 pacientes) de las mujeres menstruantes tratadas con TEPEZZA comparados con el 4% (1 de 25 pacientes) tratados con placebo en los ensayos clínicos.

**Tabla 1. Reacciones adversas que ocurrieron en más del 5% de los pacientes tratados con TEPEZZA y con mayor incidencia que el placebo**

| Reacciones adversas | TEPEZZA<br>N = 84<br>N (%) | Placebo<br>N = 86<br>N (%) |
|---|---|---|
| Espasmos musculares | 21 (25%) | 6 (7%) |
| Náuseas | 14 (17%) | 8 (9%) |
| Alopecia | 11 (13%) | 7 (8%) |
| Diarrea | 10 (12%) | 7 (8%) |
| Fatiga[a] | 10 (12%) | 6 (7%) |
| Hiperglucemia[b] | 8 (10%) | 1 (1%) |
| Insuficiencia auditiva[c] | 8 (10%) | 0 |
| Disgeusia | 7 (8%) | 0 |
| Dolor de cabeza | 7 (8%) | 6 (7%) |
| Sequedad de la piel | 7 (8%) | 0 |

[a] Fatiga incluye astenia
[b] Hiperglucemia incluye un incremento de la glucosa en sangre
[c] Insuficiencia auditiva (incluye sordera, disfunción de las trompas de Eustaquio, hiperacusia, hipoacusia y autofonia)

Inmunogenicidad

Existe la posibilidad de inmunogenicidad, como con todas las proteínas terapéuticas. La detección de la formación de anticuerpos es altamente dependiente de la sensibilidad y la especificidad del ensayo.

En un estudio controlado con placebo con TEPEZZA, 1 de 42 pacientes tratados con el placebo tuvieron niveles detectables de anticuerpos antifármaco en suero. En un estudio controlado con placebo, ninguno de 41 pacientes tratados con TEPEZZA tuvieron niveles detectables de anticuerpos

antifármaco en suero.

## 8. Cómo y por cuanto tiempo puedo guardar este medicamento?

TEPEZZA (teprotumumab) polvo liofilizado para infusión intravenosa se suministra como un polvo liofilizado estéril de color blanco a color hueso, sin conservantes, esta disponible en la siguiente presentación comercial:

| |
|---|
| Caja que contiene un vial de dosis única de 500 mg |

Refrigere a una temperatura de 2°C a 8°C en su caja original hasta el momento de su uso y protéjalo de la luz. No congelar.

MANTENGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

## 9. Información adicional

**Fabricante del Producto Terminado y Acondicionador**
Patheon Italia S.p.A.
Ferentino - Italia

**Titular e Importador**

**Titular:**
Amgen Biotecnológica S.A.S
Bogotá D.C. – Colombia

**Importador y Distribuidor:**
Amgen Biotecnológica S.A.S
Bogotá D.C. – Colombia

**Registro Sanitario**
INVIMA 2024MBT-0000125

TEP-CO-PI-001(es)
Noviembre-2024